



أهمية الرياضة في حياتنا

دليل علمي شامل
التمارين • الأوقات • العضلات

The Importance of Exercise in Our Lives

A Comprehensive Evidence-Based Guide

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

أهمية الرياضة في حياتنا

دليل علمي شامل — التمارين، الأوقات، والعضلات

The Importance of Exercise in Our Lives

A Comprehensive Evidence-Based Guide

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

الطبعة الأولى — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى كلّ من يجعل من بدنه أمانةً يرعاها، وقوّةً في طاعة ربّه...

إلى روح والدي رحمه الله، الذي علّمني أنّ الصّحةَ نعمةٌ تُصان،

إلى أمّي حفظها الله، ينبوع الدعاء،

إلى زوجتي، رفيقةِ الدرب،

إلى أولادي، أملِ الغدِ وعدّته،

إلى إخواني وأخواتي، سندي وعصدي،

أُهدي هذا الكتاب.

المحتويات

المقدمة

الفصل الأول: الرياضة والقلب والأوعية الدموية

الفصل الثاني: الرياضة والأيض — السكري والوزن والدهون

الفصل الثالث: العضلات والعظام ومقاومة الشيخوخة

الفصل الرابع: الرياضة والدماغ والصحة النفسية

الفصل الخامس: أنواع التمارين الأربعة

الفصل السادس: أهمّ التمارين وأكثرها فعالية

الفصل السابع: أهمّ عضلات الجسم وكيفية تدريبها

الفصل الثامن: أفضل وقتٍ لممارسة الرياضة

الفصل التاسع: الجرعة الموصى بها ومبادئ التدريب

الفصل العاشر: الرياضة عبر مراحل العمر

الفصل الحادي عشر: الأخطاء والإصابات والوقاية والتغذية والنوم

الفصل الثاني عشر: الرياضة في ضوء الإسلام

الخاتمة

المراجع العلمية

الترجمة الإنجليزية — English Section

نبذة عن المؤلف — About the Author

مؤلفات المؤلف — Publications

المقدمة

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأودع في جسده من بديع الصنع ما يعجز الوصف عن إحصائه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حثَّ على قوة البدن وحسن رعايته، وبعد:

لم تُعد الرياضة في زماننا ترفاً يُمارسه هواة اللياقة، بل غدت — بلغة الطب المعاصر — دواءً يُوصَف كما يُوصَف العلاج. فحين نظرت المؤسسات الطبية الكبرى إلى حجم الأدلة المتراكمة، صاغت شعاراً بات معروفاً في أوساط الأطباء: «الحركة دواء» (Exercise is Medicine)، وهي مبادرة أطلقتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي والجمعية الطبية الأمريكية سنة 2007، تدعو إلى اعتبار النشاط البدني علامةً حيوية تُسأل عنها في كل زيارة طبية.

وسبب هذا التحوّل بسيط في جوهره: قلّة الحركة صارت وباءً صامتاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت في مجلة لانسِت (Lancet) سنة 2012 بقيادة الباحثة I-Min Lee أن الخمول البدني مسؤول عن نحو 9% من الوفيات المبكرة في العالم، وأنه يضاھي في خطره التدخين والسمنة. والمقابل مبشّر: فمجرد الانتقال من الخمول إلى حدٍّ أدنى من النشاط يقلّل خطر الوفاة قليلاً ملموساً.

هذا الكتاب رحلةٌ في «لماذا» و«كيف» و«متى». نبدأ بالدليل العلمي على أثر الرياضة في القلب والأبيض والعضلات والدماغ، ثم ننتقل إلى أنواع التمارين وأهمها

فعالية، فأهم عضلات الجسم وكيفية تدريبها، ثم نجيّب عن سؤالٍ كثيراً ما يُطرح: ما أفضل وقتٍ للتمرين؟ ونختّم بالجرعة الموصى بها عالمياً، والوقاية من الإصابات، ونظرة الإسلام إلى قوة البدن.

وقد التزمْتُ في هذا الكتاب منهج الطب المبني على البينة (Evidence-Based Medicine)؛ فما كان مسنوداً بمراجعاتٍ منهجيةٍ وتجاربٍ معشاةٍ ذكرته بثقة، وما كان أضعف دليلاً نَبّهْتُ على درجته حتى لا يختلط اليقين بالظن. فالعلم أمانة، والقارئ يستحق أن يعرف قوة ما بين يديه من دليل.

﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

(التوبة: 105)

الفصل الأول: الرياضة والقلب والأوعية الدموية

القلب عضلةٌ، والعضلة تقوى بالتمرين. هذه الحقيقة البسيطة تختصر جوهر العلاقة بين الرياضة وصحة القلب. فحين نتظم في نشاطٍ هوائي، يتكيف الجهاز القلبي الوعائي تكيفاً عميقاً: يزداد حجم الضربة القلبية، ويخفض معدل النبض في الراحة، وتحسّن مرونة الأوعية، ويصير القلب أكفأ في ضخّ الدم بجهدٍ أقل.

الدليل الوبائي

من أقدم البراهين وأشهرها دراسة حافلات لندن (Morris et al., 1953) التي قارنت بين سائقي الحافلات الجالسين طوال يومهم ومُحْصلي التذاكر الذين يصعدون الدَرَج ويهبطونه؛ فوجدت أن معدل أمراض القلب التاجية بين المحصلين الأكثر حركةً أقلّ بوضوح. كانت هذه الدراسة من أوائل ما لفت الأنظار إلى أثر النشاط البدني في حماية القلب.

وتراكت بعدها الأدلة. فقد خلصت مراجعة منهجية وتحليل بعدي (meta-analysis) نُشر في مجلة Circulation إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطاً بدنياً يخفّض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تتراوح بين 20% و35% مقارنةً بالأقلّ نشاطاً، وأن العلاقة متدرّجة: كلما زاد النشاط قلّ الخطر حتى حدٍّ معين.

كيف يحمي التمرين القلب؟

• خفض ضغط الدم: يُنقص التمرين الهوائي المنتظم الضغط الانقباضي بمقدار 5-8 ملميمترات زئبق وسطياً لدى المصابين بارتفاعه، وهو أثرٌ يعادل بعض الأدوية.

• تحسين ملف الدهون: يرفع الكوليسترول النافع (HDL) ويخفض الدهون الثلاثية.

• ضبط الالتهاب: يقلل مؤشرات الالتهاب مثل بروتين سي التفاعلي (CRP).

• تحسين وظيفة البطانة الوعائية (endothelium) وزيادة إنتاج أكسيد النيتريك الموسع للأوعية.

• خفض معدل النبض في الراحة وتحسين تباين ضربات القلب (HRV) الدالّ على توازن الجهاز العصبي.

والخلاصة أن الرياضة لا تحمي القلب من طريقٍ واحد، بل عبر منظومةٍ متكاملة من التأثيرات المتضافرة. ولهذا صارت توصيات عالمية كتوصيات جمعية القلب الأمريكية (AHA) تضع النشاط البدني في صميم الوقاية من أمراض القلب.

الفصل الثاني: الرياضة والأيض – السكري والوزن والدهون

العضلة ليست أداة حركةٍ فحسب، بل هي أكبر عضوٍ أَيْضِيٍّ في الجسم يتعامل مع السكر. فحين تنقبض العضلة أثناء التمرين، تفتح أبوابها لسحب الجلوكوز من الدم بآليةٍ لا تعتمد كلياً على الإنسولين، ولهذا تُعدّ الرياضة حجر الزاوية في الوقاية من السكري من النوع الثاني وعلاجه.

الوقاية من السكري: دليل قوي

من أقوى الأدلة تجربة برنامج الوقاية من السكري (Diabetes Prevention Program) المنشورة في مجلة نيو إنجلاند الطبية سنة 2002، وهي تجربة معشاة كبيرة شملت أكثر من ثلاثة آلاف مشارك معرضين للخطر. أظهرت أن تعديل نمط الحياة – بنشاط بدني معتدل 150 دقيقة أسبوعياً مع إنقاص وزنٍ بسيط – خفض حدوث السكري بنسبة 58%، وهي نتيجة فاقت أثر دواء الميتفورمين الذي خفضه بنسبة 31%.

وهذه من النتائج النادرة التي يتفوق فيها تعديل السلوك على الدواء في تجربةٍ معشاةٍ مباشرة، ولذلك تُعدّ من أرسخ الأدلة في هذا الباب.

الرياضة وضبط الوزن

هنا يجب الدقة والأمانة العلمية: الرياضة وحدها — دون ضبط الغذاء — أثرها في إنقاص الوزن أقل مما يظنّ كثيرون، لأنّ الجسم يعوّض جزءاً من السعرات المحروقة. لكنها لا غنى عنها في أمرين حاسمين:

- الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه ومنع عودته، وهو أصعب مراحل الرّجيم.
- الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء إنقاص الوزن، فلا يكون النقصان على حساب العضل.

فالمعادلة الصحيحة: الغذاء يصنع النقصان، والحركة تحفظ الجسد وتثبت النتيجة. أما توزيع الدهون فالتمرين يقلّل الدهون الحشوية (الخطرة حول الأعضاء) حتى مع تغيير بسيط في الوزن الكلي.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^ج

(الأعراف: 31)

الفصل الثالث: العضلات والعظام ومقاومة الشيخوخة

بدءاً من نحو العقد الثالث من العمر، يفقد الإنسان الخامل نسبةً من كتلته العضلية كل عقد، وتتسارع الخسارة مع التقدم في السنّ فيما يُعرف بـ«الساركوبينيا» (sarcopenia) أو ضمور العضلات المرتبط بالعمر. وهذا الضمور ليس مسألة مظهر، بل هو من أهم أسباب الوهن والسقوط والكسور وفقدان الاستقلالية عند كبار السنّ.

تمارين المقاومة: الترياق

الخبر السارّ أن هذا المسار قابلٌ للعكس في أيّ عمر. فقد أظهرت دراسة كلاسيكية أجراها فياتاروني وزملاؤه (Fiatarone et al). ونُشرت سنة 1990 أن مسنّين تجاوزوا التسعين من العمر استطاعوا زيادة قوة عضلاتهم زيادةً كبيرة بعد أسابيع قليلة من تمارين المقاومة، وتحسّنت سرعة مشيهم وقدرتهم على النهوض. تمارين المقاومة (رفع الأثقال، أشربة المقاومة، وزن الجسم) تحفّز تخليق البروتين العضلي عبر مسار mTOR، فتبني العضلة وتقوّيها. وفوائدها تتجاوز العضل إلى:

- زيادة كثافة العظام والوقاية من هشاشتها؛ فالعظم يستجيب للحمل الواقع عليه بزيادة بنائه (قانون وولف).
- تحسين حساسية الإنسولين وضبط السكر.
- رفع معدل الأيض في الراحة، فالعضلة نسيجٌ نشطٌ يستهلك طاقة.

• تحسين التوازن والوقاية من السقوط عند كبار السن.

ولهذا أدرجت منظمة الصحة العالمية في توصياتها لعام 2020 تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعياً على الأقل لكل البالغين، لا للرياضيين وحدهم.

العظام لا تُبنى بالراحة

خلافًا لما قد يُظنّ، الراحة التامة تُضعف العظم لا تحميه. فالعظم نسيجٌ حيٌّ يتجدّد باستمرار، ويحتاج إلى حملٍ ميكانيكي (كالمشي والقفز ورفع الأثقال) ليحافظ على كثافته. وأنجح التمارين للعظم هي التمارين الحاملة للوزن وتمارين المقاومة.

الفصل الرابع: الرياضة والدماغ والصحة النفسية

لم يُعدّ نفع الرياضة مقصوراً على القلب والعضل، بل امتدّ البحث إلى الدماغ نفسه. فالنشاط البدني يزيد تدفق الدم إلى المخ، ويحفّز إفراز عوامل نموّ عصبية أبرزها العامل المُشتقّ من الدماغ (BDNF) الذي يُشبّه بـ«السماذ» الذي يغذّي الخلايا العصبية ويعزّز تكوين وصلاتٍ جديدة.

الاكتئاب والقلق

تراكمت أدلة قوية على أثر الرياضة في تحسين المزاج. فقد خلصت مراجعة شاملة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي (British Journal of Sports Medicine) سنة 2023 بقيادة سينغ (Singh et al)، جمعت مئات التجارب، إلى أن النشاط البدني فعّال في خفض أعراض الاكتئاب والقلق، وأن أثره يضاهي في بعض السياقات العلاجات المعتادة، خصوصاً في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

ومع ذلك، تبقى الرياضة مكّماً لا بديلاً عن العلاج الطبي في الحالات المتوسطة والشديدة؛ فمن يعاني اضطراباً نفسياً ينبغي أن يستشير المختص، وتكون الرياضة جزءاً من خطة متكاملة لا حلاً منفرداً.

الذاكرة والوقاية من التدهور المعرفي

تشير دراسات الرصد إلى أن كبار السن الأكثر نشاطاً بدنياً أقل عرضةً للتدهور المعرفي والخرف. والتمارين الهوائية على وجه الخصوص ارتبطت بزيادة حجم الحصين (hippocampus) – مركز الذاكرة – في تجارب على البالغين. وإن كانت هذه الأدلة رصديةً في معظمها لا تثبت السببية القاطعة، فإنها متسقة ومشجعة.

ولا ننسى الأثر الفوري: جرعة واحدة من التمرين المعتدل تحسن التركيز والمزاج ساعاتٍ بعده، بفضل إفراز النواقل العصبية كالإندورفين والدوبامين والسيروتونين.

الفصل الخامس: أنواع التمارين الأربعة

يُخطئ من يَحصر الرياضة في نوع واحد. فالبرنامج المتكامل يقوم على أربعة أعمدة، لكلٍّ منها فائدته التي لا يسدها غيره:

(1) التمارين الهوائية (Aerobic / Cardio)

وهي التي ترفع النبض وتُبقّيه مرتفعاً مدةً متصلة: المشي السريع، الجري، السباحة، الدراجة. فائدتها الكبرى للقلب والرئتين والأيض والتحمل. وهي العمود الأهم لطول العمر وصحة القلب.

(2) تمارين المقاومة (Strength / Resistance)

رفع الأثقال، أشربة المقاومة، تمارين وزن الجسم. تبني العضل وتقوي العظم وترفع الأيض. لا غنى عنها لمقاومة الشيخوخة والحفاظ على الاستقلالية.

(3) تمارين المرونة والإطالة (Flexibility)

الإطالات واليوغا وحركات الإطالة الديناميكية. تحافظ على مدى حركة المفاصل وتقلّل التيبس. الأنسب أداء الإطالة الساكنة بعد الإحماء أو في نهاية التمرين، لا على عضلٍ بارد.

(4) تمارين التوازن (Balance)

الوقوف على قدمٍ واحدة، تمارين تاي تشي. بالغة الأهمية لكبار السنّ للوقاية من السقوط الذي هو سبب رئيس للكسور وفقدان الاستقلالية. أثبتت مراجعات كوكرين (Cochrane) فاعليتها في خفض السقوط.

البرنامج الأمثل يجمع الأربعة بحسب العمر والهدف؛ فالشباب الرياضي يُغلبُ القوة والتحمل، والكهل يعتني بالتوازن والمرونة إلى جانبهما.

الفصل السادس: أهمّ التمارين وأكثرها فعالية

إذا سُئِلنا: ما أكثر التمارين مردوداً لكل دقيقة تُبذل فيها؟ فالجواب يدور حول مبدأ واحد: التمارين المركّبة (compound) التي تُشغّل عدّة مفاصل ومجموعات عضلية معاً على مرّدوداً من التمارين المعزولة التي تستهدف عضلةً واحدة.

أفضل التمارين المركّبة

- القرفصاء (Squat): ملكة تمارين الجزء السفلي؛ تُشغّل الفخذين والأرداف وأسفل الظهر وعضلات الجذع معاً.
- الرفعة المميّنة (Deadlift): من أشمل التمارين للسلسلة الخلفية (الظهر، الأرداف، أوتار الركبة)؛ تُؤدّي بتقنية سليمة تحمي الظهر.
- الضغط بالصدر أو تمرين الاستناد (Push-up / Bench press): للصدر والكتف والعضلة ثلاثية الرؤوس.
- السحب والعقلة (Rows / Pull-up): لعضلات الظهر العريضة والعضلة ذات الرأسين.
- الاندفاع (Lunge): للفخذين والأرداف مع تحسين التوازن.

المشي: أبسط دواءٍ وأوسعُه

لا يستهن أحدٌ بالمشي. فهو متاحٌ للجميع، قليل الإصابات، وأدلته على طول العمر قوية. وقد بددت دراساتٌ حديثة أسطورة «العشرة آلاف خطوة» بوصفها رقماً سحرياً، إذ أظهر تحليلٌ نُشر في The Lancet Public Health سنة 2022 بقيادة بانياخ (Paluch et al). أن الفائدة تبدأ من بضعة آلاف خطوة وتتصاعد حتى نحو 6000-8000 خطوة يومياً لكبار السنّ، وأعلى قليلاً للأصغر سناً، ثم يقلّ العائد الإضافي. فالرسالة: كلّ خطوةٍ تنفع، ولا حاجة للتقيّد برقم صارم.

التدريب المتقطّع عالي الشدّة (HIIT)

وهو تناوبٌ بين نوباتٍ قصيرة شديدة وفتراتٍ راحة. يوفر فوائدٍ قلبية وأيضية مماثلة للتمرين المعتدل المطول لكن في وقتٍ أقصر، ما يجعله خياراً لمن يشكو ضيق الوقت. لكنه أشدّ إجهاداً، ويُصح بالتدرّج فيه واستشارة الطبيب لمن لديه مشكلات قلبية.

الفصل السابع: أهم عضلات الجسم وكيفية تدريبها

جسم الإنسان يضمّ أكثر من ستمئة عضلة، لكن قِلةً منها تحمل عبء الحركة والقوام والاستقلالية اليومية. ومعرفة هذه العضلات الكبرى وكيفية تدريبها هي مفتاح برنامج متوازن يقي من الاختلال والإصابة.

عضلات الجذع (Core)

وتشمل عضلات البطن المستقيمة والمائلة والعضلة المستعرضة وعضلات أسفل الظهر. هي مركز الثقل ومصدر الاتزان، وقوتها تقي من آلام أسفل الظهر. أفضل تمارينها: البلاנק (Plank)، والجسر (Bridge)، وحركات مقاومة الالتفاف، لا الطحن (crunches) وحده.

عضلات الأرداف والخذ

العضلة الأليوية الكبرى (glutes) من أقوى عضلات الجسم ومحرك رئيس للمشي والصعود والوقوف. ضعفها شائع بسبب الجلوس الطويل، ويسبب آلام الركبة والظهر. تُدرّب بالقرفصاء ورفع الحوض (hip thrust) والاندفاع.

السلسلة الخلفية (الظهر وأوتار الركبة)

عضلات الظهر العريضة والمنصبة وأوتار الركبة الخلفية. الجلوس الطويل يُضعفها فيختلّ القوام. تُقوّى بالسحب والرفعة المميّنة والتجديف.

عضلات الساق

عضلة الساق الخلفية (بطة الساق) والعضلات الأمامية. مهمةٌ للتوازن ودفع الدم من الأطراف السفلى نحو القلب («القلب الثاني»). يُقوِّمها المشي على أطراف الأصابع والقفز الخفيف.

قاعدة ذهبية: التوازن بين الدافعة والساحبة

من أشيع أخطاء المبتدئين تدريب العضلات «المرئية» في المرأة (الصدر والذراع الأمامية) وإهمال الظهر والسلسلة الخلفية، فينشأ اختلالٌ عضليٌّ يؤدي القوام والكتف. القاعدة: لكل تمرين دفع (push) تمرين سحب (pull) يوازنه، ولكل عضلةٍ أمامية شقيقةٌ خلفية تُدرَّب معها.

الفصل الثامن: أفضل وقت لممارسة الرياضة

سؤالٌ يتردّد كثيراً: أصبحاً أم مساءً؟ والجواب العلمي الصادق: أفضل وقتٍ هو الوقت الذي تلتزم به فعلاً وباستمرار. فالانتظام يتفوّق على أيّ توقيتٍ «مثالي» نظري. ومع ذلك، ثمة فروق طفيفة أظهرها البحث:

تمرين الصباح

- أنسب لبناء العادة والالتزام، إذ لا تراحه مشاغل اليوم.
- قد يعين على ضبط إيقاع النوم والاستيقاظ.
- التمرين قبل الفطور (على الصائم) قد يزيد أكسدة الدهون قليلاً، لكن أثره في إنقاص الوزن الكلي محدود ومتنازعٌ فيه.

تمرين المساء

- الأداء البدني (القوة والقدرة) يبلغ ذروته غالباً بعد الظهر والمساء، حين ترتفع حرارة الجسم قليلاً وتكون العضلات أكثر استعداداً.
- قد يكون خطر الإصابة أقلّ لأن الجسم دافئٌ ومهيأٌ.
- يُنصح بتجنّب التمرين الشديد جداً قبل النوم مباشرةً عند بعض الناس لئلا يؤخّر النوم، وإن كان هذا يتفاوت بين الأفراد.

الخلاصة

لا يوجد وقتٌ «سحري» يصلح للجميع. اختر ما يناسب جدولك ويستطيع جسدك الالتزام به. إن كان هدفك القوة القصوى فقد يميل الميزان قليلاً نحو المساء، وإن كان هدفك بناء عادةٍ راسخةٍ فالصباح أعون. والأهم: أن تمارس، لا متى تمارس.

الفصل التاسع: الجرعة الموصى بها ومبادئ التدريب

كما للدواء جرعةٌ محسوبة، للرياضة جرعةٌ أوصت بها منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها المحدثة سنة 2020 للبالغين (18-64 سنة):

- من 150 إلى 300 دقيقة أسبوعياً من النشاط الهوائي المعتدل، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط الشديد، أو مزيجاً منهما.
- تمارين تقوية العضلات لجميع المجموعات الكبرى مرتين أسبوعياً على الأقل.
- ل كبار السنّ: إضافة تمارين التوازن ثلاث مرّات أسبوعياً أو أكثر للوقاية من السقوط.
- تقليل زمن الجلوس والنمول، فـ«أيّ حركةٍ خيرٌ من لا حركة».
- ورسالة الإرشادات الجوهرية: قليلٌ من النشاط خيرٌ من لا شيء، والمزيد أفضل حتى حدٍّ معقول. فلا ينبغي لمن عجز عن بلوغ الحدّ الكامل أن ييأس؛ فالمتحنى بين النشاط والفائدة أشدّ انحداراً في بدايته.

مبادئ التدريب الأربعة (FITT)

- التكرار (Frequency): كم مرّة في الأسبوع.

- الشدّة (Intensity): مدى صعوبة الجهد؛ يُقاس بمعدل النبض أو باختبار الكلام (إن عجزت عن الكلام فالشدّة عالية).
- المدة (Time): طول الحصة.
- النوع (Type): هوائي أم مقاومة أم غيرهما.

مبدأ الحمل الزائد المتدرّج

لتتحسّن اللياقة يجب أن يتعرّض الجسم لحمل أكبر قليلاً مما اعتاد، بزيادةٍ متدرّجة في الوزن أو التكرار أو المدة. لكن التدرّج شرطٌ للسلامة؛ فالفقر المفاجئ في الحمل أشيع أسباب الإصابة. وقاعدة تقرّيبية شائعة: لا تزيد حملك الأسبوعي بأكثر من نحو 10% كلّ أسبوع.

الراحة والاستشفاء

العضلة لا تنمو أثناء التمرين، بل أثناء الراحة بعده. لذا فأيام الراحة والنوم الكافي جزءٌ من البرنامج لا خارجٌ عنه. والإفراط بلا استشفاء يؤدّي إلى فرط التدريب (overtraining) وتراجع الأداء والإصابة.

الفصل العاشر: الرياضة عبر مراحل العمر

الأطفال والمراهقون (5-17 سنة)

توصي منظمة الصحة العالمية بـ 60 دقيقة يومياً على الأقل من النشاط المعتدل إلى الشديد، معظمه هوائي، مع تمارين تقوي العظم والعضل ثلاث مرّات أسبوعياً (كالقفز واللعب النشط). فهذه المرحلة تبني ذروة الكتلة العظمية التي ترافق الإنسان عمره.

البالغون (18-64 سنة)

تنطبق عليهم الجرعة المذكورة في الفصل السابق: 150-300 دقيقة هوائي أسبوعياً + تقوية مرّتين. والتحدّي الأكبر في هذه المرحلة هو الوقت، وحلّه دمج الحركة في اليوم: الدرج بدل المصعد، والمشي في المكالمات، والدراجة للتنقل.

كبار السنّ (65 سنة فأكثر)

لهم أهمية خاصة لتمرّين التوازن والمقاومة للوقاية من السقوط والحفاظ على الاستقلالية. والقاعدة الذهبية: ليس العمر مانعاً من التمرين، بل التمرين هو ما يحفظ شباب الجسد. ويبدأ بالتدرّج وبإشراف عند وجود أمراض مزمنة.

المرأة الحامل

النشاط المعتدل المنتظم آمنٌ ومفيدٌ في الحمل الطبيعي، ويقلّل سكري الحمل وتسمّمه ويحسن المزاج والنوم، شريطة استشارة الطبيب وتجنّب الرياضات عالية الخطر والاستلقاء الطويل على الظهر في المراحل المتأخرة.

أصحاب الأمراض المزمنة

لمرضى القلب والسكري والكلّي ومن في حكمهم، الرياضة مفيدةٌ بل موصى بها، لكن بجرعةٍ وإشرافٍ مخصّصين. والقاعدة: استشر طبيبك قبل البدء ببرنامجٍ جديد إن كنت تعاني مرضاً مزمناً أو أعراضاً كآلم الصدر عند الجهد.

الفصل الحادي عشر: الأخطاء والإصابات والوقاية والتغذية والنوم

أشيع الأخطاء

- البدء بحماسٍ مفرط ثم الانقطاع؛ والأصوب التدرّج البطيء المستدام.
- إهمال الإحماء قبل التمرين والتهديئة بعده.
- القفز المفاجئ في الأوزان أو المسافات (تجاوز قاعدة 10%).
- إهمال تقنية الأداء الصحيحة، وهي أهمّ من الوزن المرفوع.
- إهمال النوم والتغذية والاستشفاء.
- المقارنة بالآخرين بدل التركيز على التقدّم الشخصي.

الوقاية من الإصابات

- إحماءً ديناميكي 5-10 دقائق قبل الجهد.
- تعلّم التقنية الصحيحة من مصدرٍ موثوق قبل زيادة الحمل.
- الإصغاء إلى الجسد؛ فالألم الحادّ إشارة توقّف لا تحدّ.
- التدرّج المتّزن في الحمل، وإدراج أيام راحة.

التغذية حول التمرين

البروتين لبننة العضل؛ يوصى بنحو 1.2 إلى 2.0 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً لمن يتدرّب بانتظام، موزعاً على الوجبات. والكربوهيدرات وقود الجهد، والماء ضروريٌّ للأداء ودفع الإجهاد الحراري. ولا حاجة لغالب الناس إلى المكملات المكلفة؛ فالغذاء المتوازن يكفي، والأصل الطعام لا الحبوب.

النوم

النوم الكافي (7-9 ساعات للبالغين) شرطٌ للاستشفاء وبناء العضل وضبط الهرمونات. وقد يهدم قلة النوم ما يبنيه التمرين. فالنوم ليس ترفاً بل ركنٌ من أركان اللياقة.

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ﴾

(النبا: 9-10)

الفصل الثاني عشر: الرياضة في ضوء الإسلام

عني الإسلام بالبدن عنايةً بالغة، وجعله أمانةً يُسأل عنها العبد. فالجسد القويّ خير يُعين على العبادة والعمل والنفع، والقوّة في الشرع محدودةٌ إذا اقترنت بالأمانة.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ﴾

(القصص: 26)

﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾

(البقرة: 247)

وقد أثنى الله على طالوت بجمعه بين سعة العلم وقوة الجسم، إشارةً إلى أن كمال القيادة يجمع بين قوّة العقل وقوّة البدن. وفي السنّة يقول النبي ﷺ:

«المؤمن القويّ خيرٌ وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير.»

رواه مسلم

والقوّة هنا تشمل قوّة البدن كما تشمل قوّة الإيمان والعزيمة؛ وفي ذكرها في سياق الأفضلية إشارةً إلى مطلوبة العناية بالجسد. وقد صحّ عن النبي ﷺ أنه أرشد إلى أنّ للبدن حقّاً على صاحبه:

«إِنَّ لَبَدَنكَ عَلَيْكَ حَقًّا.»

متفق عليه

وأما ما اشتهر من الحث على تعليم الأبناء «السباحة والرماية وركوب الخيل» فالأشهر أنه من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أثرٌ موقوف) لا حديثٌ مرفوعٌ صحيحٌ عن النبي ﷺ، وهو مع ذلك أصلٌ صحيحٌ المعنى في تربية القوة البدنية، وقد ثبت في السنة سباق النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها ومسابقة الصحابة على أقدامهم، ومصارعته ركانة، ورمي الأسلمين بالنبل بحضرته وتشجيعه لهم. فالرياضة في الميزان الشرعي مطلوبةٌ ما دامت وسيلةً لقوةٍ نافعة، منضبطةً بضوابط الشرع في الستر وعدم الإسراف وترك ما يُلهي عن الفرائض. وبهذا تلتقي حكمة الشرع مع خلاصة العلم: أنَّ العناية بالبدن أمانةٌ وعبادة.

الختامة

بلغنا ختام هذه الرحلة، وقد اتّضح أن الرياضة ليست ترفاً يُؤجّل، بل ضرورةٌ صحية يشهد لها العلم بأقوى أدلّته. رأينا كيف تحمي القلب، وتقي من السكري، وتبني العضل والعظم، وتغذي الدماغ وتصفي المزاج، وكيف أن جرعةً متواضعة من الحركة تصنع فرقاً في طول العمر وجودته.

والرسائل الكبرى التي نودّ أن تبقى بعد طيّ الصفحات ثلاث: أولاً أن قليلاً من النشاط خيرٌ من لا شيء، فلا يُعدنك الكمال عن الشروع. وثانيها أن الانتظام أهمّ من الشدّة والتوقيت؛ فعادةٌ صغيرة تدوم خيرٌ من حماسةٍ تنطفئ. وثالثها أن التوازن — بين هوائيٍّ ومقاومةٍ ومرونةٍ وتوازن، وبين تدريبٍ وراحةٍ وغذاءٍ ونوم — هو سرّ الاستدامة والسلامة.

فابدأ اليوم بخطوة، وليكن بدنك أمانةً ترعاها، فإنّ فيه من آيات الخالق ما يستحقّ الشكر بحسن الرعاية. نسأل الله أن يرزقنا صحةً في أبداننا وقوّةً في طاعته.

والله أعلم.

المراجع العلمية

رُتِبَتِ المراجع بحسب المجال، وذُكِرَت بأسماء الباحثين والمجلات والسنوات توثيقاً للأمانة العلمية.

علم القلب والأوعية (Cardiology & Epidemiology)

1. Morris JN, et al. Coronary heart-disease and physical activity of work. The Lancet, 1953.
2. Lee I-M, et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide. The Lancet, 2012.
3. Nocon M, et al. Association of physical activity with all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Prevention, 2008.
4. Arnett DK, et al. ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease. Circulation, 2019.

الأيض والسكري (Metabolism & Diabetes)

1. Knowler WC, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin (DPP). New England Journal of Medicine, 2002.

2. Colberg SR, et al. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care, 2016.

(Musculoskeletal) العضلات والعظام

1. Fiatarone MA, et al. High-intensity strength training in nonagenarians. JAMA, 1990.
2. Cruz-Jentoft AJ, et al. Sarcopenia: revised European consensus (EWGSOP2). Age and Ageing, 2019.

(Brain & Mental Health) الدماغ والصحة النفسية

1. Singh B, et al. Effectiveness of physical activity interventions for depression, anxiety and distress. British Journal of Sports Medicine, 2023.
2. Erickson KI, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. PNAS, 2011.

(Walking & Global Guidelines) المشي والتوصيات العالمية

1. Paluch AE, et al. Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis. The Lancet Public Health, 2022.

2. Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine, 2020.

التفسير وعلوم القرآن (Qur'anic Exegesis / Tafsir)

1. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم – تفسير آية «القويّ الأمين» (القصص) وآية طالت «بسطة في العلم والجسم» (البقرة).
2. الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن – تفسير قوله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (البقرة).
3. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن – تفسير «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» (الأعراف).
4. النووي، شرح صحيح مسلم – شرح حديث «المؤمن القويّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله».

English Section

القسم الإنجليزي

Full translation of the book

Introduction

Praise be to God, who created the human being in the finest form and placed within the body marvels of design beyond counting; and peace be upon our Prophet Muhammad, who urged us toward bodily strength and its careful stewardship.

In our age, exercise is no longer a luxury pursued by fitness enthusiasts; in the language of modern medicine it has become a treatment prescribed much like any therapy. Surveying the mass of accumulated evidence, major medical bodies coined a slogan now familiar among physicians: “Exercise is Medicine”—an initiative launched by the American College of Sports Medicine and the American Medical Association in 2007, calling for physical activity to be treated as a vital sign asked about at every clinical visit.

The reason for this shift is simple at its core: inactivity has become a silent epidemic. A 2012 study in *The Lancet*, led by I-Min Lee, estimated that physical inactivity is responsible for roughly 9% of premature deaths worldwide, rivalling smoking

and obesity in its harm. The upside is encouraging: merely moving from inactivity to a minimum of activity measurably lowers the risk of death.

This book is a journey through the “why,” the “how,” and the “when.” We begin with the scientific evidence for exercise's effect on the heart, metabolism, muscle, and brain; then turn to the types of exercise and the most effective among them, the body's key muscles and how to train them; then answer a frequent question—what is the best time to train?—and close with the globally recommended dose, injury prevention, and Islam's view of bodily strength.

Throughout, I have followed the method of Evidence-Based Medicine: what is backed by systematic reviews and randomized trials I state with confidence, and what rests on weaker evidence I flag as such, so certainty is not confused with conjecture. Science is a trust, and the reader deserves to know the strength of the evidence in hand.

﴿ And say: Work, for God will see your work,
and so will His Messenger and the believers. ﴾

(At-Tawbah: 105)

Chapter 1: Exercise and Cardiovascular Health

The heart is a muscle, and a muscle grows stronger with training. This simple truth captures the essence of the relationship between exercise and heart health. With regular aerobic activity the cardiovascular system adapts deeply: stroke volume rises, resting heart rate falls, vessels become more elastic, and the heart pumps blood more efficiently with less effort.

Epidemiological Evidence

Among the earliest and most famous proofs is the London Bus Study (Morris et al., 1953), which compared bus drivers seated all day with conductors climbing and descending stairs; it found notably lower rates of coronary heart disease among the more active conductors—one of the first works to draw attention to physical activity's protective effect on the heart.

Evidence accumulated thereafter. A systematic review and meta-analysis published in *Circulation* concluded that the most

physically active people have a 20–35% lower risk of coronary heart disease than the least active, and that the relationship is graded: the more activity, the lower the risk, up to a point.

How Does Exercise Protect the Heart?

- Lowering blood pressure: regular aerobic exercise reduces systolic pressure by an average of 5–8 mmHg in those with hypertension—an effect comparable to some medications.
- Improving the lipid profile: raising beneficial HDL cholesterol and lowering triglycerides.
- Controlling inflammation: reducing markers such as C-reactive protein (CRP).
- Improving endothelial function and increasing production of vessel-dilating nitric oxide.
- Lowering resting heart rate and improving heart-rate variability (HRV), a sign of autonomic balance.

In short, exercise protects the heart not by one path but through an integrated system of converging effects. This is why global

recommendations, such as those of the American Heart Association, place physical activity at the heart of cardiovascular prevention.

Chapter 2: Exercise and Metabolism— Diabetes, Weight, and Fat

Muscle is not merely an organ of movement; it is the body's largest metabolic organ for handling sugar. When muscle contracts during exercise, it opens gates to draw glucose from the blood by a mechanism not wholly dependent on insulin—which is why exercise is a cornerstone of preventing and treating type 2 diabetes.

Preventing Diabetes: Strong Evidence

Among the strongest evidence is the Diabetes Prevention Program, published in the New England Journal of Medicine in 2002—a large randomized trial of over three thousand at-risk participants. It showed that lifestyle modification—150 minutes of moderate activity weekly with modest weight loss—reduced the incidence of diabetes by 58%, a result exceeding the drug metformin, which reduced it by 31%.

This is one of the rare instances where behavior change outperforms medication in a direct randomized trial, making it among the most robust findings in this field.

Exercise and Weight Control

Here honesty is required: exercise alone—without dietary control—has a smaller effect on weight loss than many suppose, because the body compensates for part of the calories burned. Yet it is indispensable in two decisive respects:

- Maintaining weight after loss and preventing regain—the hardest phase of any diet.
- Preserving muscle mass during weight loss, so the loss is not at the expense of muscle.

The correct equation: diet drives the loss, while movement protects the body and locks in the result. As for fat distribution, exercise reduces dangerous visceral fat even with little change in total weight.

﴿ Eat and drink, but do not be excessive; indeed

He does not love the excessive. ﴾

(Al-A'raf: 31)

Chapter 3: Muscle, Bone, and Resisting Aging

From around the third decade of life, an inactive person loses a share of muscle mass each decade, and the loss accelerates with age in what is known as sarcopenia—age-related muscle wasting. This is not a matter of appearance; it is among the chief causes of frailty, falls, fractures, and lost independence in the elderly.

Resistance Training: The Antidote

The good news is that this path is reversible at any age. A classic study by Fiatarone and colleagues, published in 1990, showed that nonagenarians—people past ninety—substantially increased their muscle strength after just a few weeks of resistance training, improving their walking speed and ability to rise.

Resistance training (weights, resistance bands, bodyweight) stimulates muscle protein synthesis via the mTOR pathway,

building and strengthening muscle. Its benefits extend beyond muscle to:

- Increasing bone density and preventing osteoporosis; bone responds to the load placed upon it by building more (Wolff's law).
- Improving insulin sensitivity and glucose control.
- Raising resting metabolic rate, since muscle is metabolically active tissue.
- Improving balance and preventing falls in the elderly.

This is why the World Health Organization's 2020 recommendations include muscle-strengthening exercise at least twice weekly for all adults—not athletes alone.

Bones Are Not Built by Rest

Contrary to what one might assume, complete rest weakens bone rather than protecting it. Bone is living tissue in constant renewal, requiring mechanical load (walking, jumping, lifting) to maintain its density. The most effective exercises for bone are weight-bearing and resistance exercises.

Chapter 4: Exercise, the Brain, and Mental Health

The benefits of exercise are no longer confined to heart and muscle; research now reaches the brain itself. Physical activity increases blood flow to the brain and stimulates neurotrophic growth factors, foremost among them Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), likened to a “fertilizer” that nourishes neurons and fosters new connections.

Depression and Anxiety

Strong evidence has accumulated for exercise's effect on mood. A comprehensive review in the British Journal of Sports Medicine in 2023, led by Singh and colleagues and pooling hundreds of trials, concluded that physical activity is effective in reducing symptoms of depression and anxiety, its effect rivalling standard treatments in some contexts, especially in mild-to-moderate cases.

Even so, exercise remains a complement, not a substitute, for medical treatment in moderate and severe cases; anyone with a psychological disorder should consult a specialist, with exercise forming part of an integrated plan rather than a standalone solution.

Memory and Preventing Cognitive Decline

Observational studies suggest that more physically active older adults are less prone to cognitive decline and dementia. Aerobic exercise in particular has been linked to increased hippocampal volume—the memory center—in trials on adults. Though this evidence is largely observational and does not prove definitive causation, it is consistent and encouraging.

Nor should we forget the immediate effect: a single bout of moderate exercise improves focus and mood for hours afterward, thanks to the release of neurotransmitters such as endorphins, dopamine, and serotonin.

Chapter 5: The Four Types of Exercise

It is a mistake to confine exercise to a single type. A complete program rests on four pillars, each with a benefit no other can supply:

1) Aerobic Exercise (Cardio)

Activities that raise the heart rate and keep it elevated continuously: brisk walking, running, swimming, cycling. Their great benefit is to the heart, lungs, metabolism, and endurance. This is the most important pillar for longevity and heart health.

2) Resistance / Strength Training

Weightlifting, resistance bands, bodyweight exercises. They build muscle, strengthen bone, and raise metabolism. Indispensable for resisting aging and preserving independence.

3) Flexibility Training

Stretching, yoga, and dynamic mobility work. They preserve joint range of motion and reduce stiffness. Static stretching is

best done after warming up or at the end of a session, not on a cold muscle.

4) Balance Training

Standing on one leg, Tai Chi. Crucial for the elderly to prevent falls—a leading cause of fractures and lost independence.

Cochrane reviews have confirmed its effectiveness in reducing falls.

The ideal program combines all four according to age and goal; a young athlete emphasizes strength and endurance, while an older adult attends to balance and flexibility alongside them.

Chapter 6: The Most Effective Exercises

If asked which exercises give the greatest return for every minute invested, the answer turns on one principle: compound exercises—engaging several joints and muscle groups together—yield more than isolation exercises targeting a single muscle.

The Best Compound Exercises

- Squat: the queen of lower-body movements; it engages the thighs, glutes, lower back, and core together.
- Deadlift: among the most complete exercises for the posterior chain (back, glutes, hamstrings); performed with proper technique to protect the back.
- Push-up / Bench Press: for chest, shoulders, and triceps.
- Rows / Pull-up: for the broad back muscles and biceps.
- Lunge: for thighs and glutes while improving balance.

Walking: The Simplest, Most Accessible Medicine

Let no one underrate walking. It is available to all, low in injury risk, and strong in its longevity evidence. Recent studies have dispelled the myth of “10,000 steps” as a magic number; an analysis in *The Lancet Public Health* in 2022, led by Paluch and colleagues, showed benefit beginning at a few thousand steps and rising to around 6,000–8,000 daily for older adults—slightly higher for the younger—after which additional return diminishes. The message: every step helps, with no need to fixate on a rigid figure.

High-Intensity Interval Training (HIIT)

Alternating short intense bouts with rest periods, HIIT offers cardiovascular and metabolic benefits similar to prolonged moderate exercise but in less time, making it an option for the time-pressed. It is more demanding, however, so gradual progression and, for those with cardiac issues, medical consultation are advised.

Chapter 7: The Body's Key Muscles and How to Train Them

The human body contains over six hundred muscles, but a few bear the burden of movement, posture, and daily independence. Knowing these major muscles and how to train them is the key to a balanced program that guards against imbalance and injury.

The Core

Comprising the rectus and oblique abdominals, the transverse abdominis, and the lower back muscles. It is the center of gravity and source of balance, and its strength guards against lower-back pain. Best exercises: the plank, the bridge, and anti-rotation movements—not crunches alone.

Glutes and Thighs

The gluteus maximus is among the body's strongest muscles and a prime mover for walking, climbing, and standing. Its weakness is common from prolonged sitting and causes knee and back pain. Trained with squats, hip thrusts, and lunges.

The Posterior Chain (Back and Hamstrings)

The broad back muscles, the traps, and the hamstrings.

Prolonged sitting weakens them and posture suffers.

Strengthened by rows, deadlifts, and rowing movements.

The Calf Muscles

The calf (gastrocnemius) and the anterior leg muscles. Important for balance and for pumping blood from the lower limbs back to the heart (the “second heart”). Strengthened by calf raises and light jumping.

A Golden Rule: Balance Push and Pull

A common beginner error is training the “mirror” muscles (chest and front arm) while neglecting the back and posterior chain, producing a muscular imbalance that harms posture and the shoulder. The rule: for every push exercise, a balancing pull; and for every front muscle, a posterior counterpart trained alongside it.

Chapter 8: The Best Time to Exercise

A frequent question: morning or evening? The honest scientific answer: the best time is the one you will actually keep to, consistently. Consistency outweighs any theoretically “ideal” timing. Still, research has shown slight differences:

Morning Exercise

- Better for building the habit and consistency, since the day's demands do not yet compete with it.
- May help regulate the sleep–wake rhythm.
- Fasted exercise before breakfast may slightly increase fat oxidation, but its effect on total weight loss is limited and debated.

Evening Exercise

- Physical performance (strength and power) often peaks in the afternoon and evening, when body temperature is slightly higher and muscles are more prepared.

- Injury risk may be lower because the body is warm and primed.
- Very intense exercise right before bed is best avoided in some people lest it delay sleep, though this varies between individuals.

Conclusion

There is no “magic” time that suits everyone. Choose what fits your schedule and what your body can sustain. If your goal is maximal strength, the balance may tip slightly toward the evening; if your goal is a firm habit, the morning is more helpful. Most important is that you exercise—not when.

Chapter 9: The Recommended Dose and Training Principles

Just as medicine has a measured dose, so does exercise—one the World Health Organization set out in its updated 2020 guidelines for adults (18–64 years):

- 150 to 300 minutes weekly of moderate aerobic activity, or 75 to 150 minutes of vigorous activity, or a combination.
- Muscle-strengthening exercises for all major groups at least twice weekly.
- For older adults: adding balance exercises three or more times weekly to prevent falls.
- Reducing sitting and sedentary time, for “any movement is better than none.”

The guidelines' core message: a little activity is better than none, and more is better up to a reasonable point. Those unable to

reach the full target should not despair; the curve between activity and benefit is steepest at its start.

The Four Training Principles (FITT)

- Frequency: how many times per week.
- Intensity: how hard the effort; gauged by heart rate or the talk test (if you cannot speak, intensity is high).
- Time: the length of the session.
- Type: aerobic, resistance, or otherwise.

Progressive Overload

For fitness to improve, the body must face a load slightly greater than it is used to, with gradual increases in weight, repetitions, or duration. Yet gradualness is a condition of safety; a sudden jump in load is the commonest cause of injury. A common rule of thumb: do not increase your weekly load by more than about 10% each week.

Rest and Recovery

Muscle does not grow during exercise but during the rest afterward. Rest days and adequate sleep are therefore part of the program, not outside it. Excess without recovery leads to overtraining, declining performance, and injury.

Chapter 10: Exercise Across the Ages

Children and Adolescents (5–17 years)

The WHO recommends at least 60 minutes daily of moderate-to-vigorous activity, most of it aerobic, with bone- and muscle-strengthening activity three times weekly (jumping, active play). This stage builds the peak bone mass that accompanies a person for life.

Adults (18–64 years)

The dose from the previous chapter applies: 150–300 minutes of aerobic activity weekly plus strengthening twice. The greatest challenge here is time, solved by weaving movement into the day: stairs instead of the elevator, walking during calls, cycling for commutes.

Older Adults (65+)

Balance and resistance training are especially important for preventing falls and preserving independence. The golden rule: age is no barrier to exercise; rather, exercise is what keeps the

body young. Begin gradually and under supervision where chronic illness is present.

Pregnant Women

Regular moderate activity is safe and beneficial in a normal pregnancy, reducing gestational diabetes and pre-eclampsia and improving mood and sleep—provided a doctor is consulted and high-risk sports and prolonged supine positions in late stages are avoided.

Those with Chronic Illness

For patients with heart, diabetic, or kidney disease and the like, exercise is beneficial and indeed recommended, but at a tailored dose and with supervision. The rule: consult your physician before starting a new program if you have a chronic illness or symptoms such as chest pain on exertion.

Chapter 11: Errors, Injuries, Prevention, Nutrition, and Sleep

The Commonest Errors

- Starting with excessive zeal then quitting; the wiser course is slow, sustainable progression.
- Neglecting the warm-up before and the cool-down after.
- A sudden jump in weights or distances (breaking the 10% rule).
- Neglecting correct technique, which matters more than the weight lifted.
- Neglecting sleep, nutrition, and recovery.
- Comparing oneself to others instead of focusing on personal progress.

Preventing Injuries

- A dynamic warm-up of 5–10 minutes before exertion.

- Learning correct technique from a trusted source before increasing load.
- Listening to the body; sharp pain is a signal to stop, not a challenge.
- Measured, gradual progression in load, with rest days built in.

Nutrition Around Exercise

Protein is the building block of muscle; about 1.2 to 2.0 grams per kilogram of body weight daily is recommended for those training regularly, spread across meals. Carbohydrates fuel effort, and water is essential for performance and heat stress. Most people need no costly supplements; a balanced diet suffices, and food comes before pills.

Sleep

Adequate sleep (7–9 hours for adults) is a condition of recovery, muscle building, and hormonal balance. Too little sleep can undo what exercise builds. Sleep is no luxury but a pillar of fitness.

﴿ And We made your sleep for rest, and We
made the night a covering. ﴾

(An-Naba': 9-10)

Chapter 12: Exercise in the Light of Islam

Islam gave great attention to the body, making it a trust for which the servant is accountable. A strong body is a good that aids worship, work, and benefit, and strength is praised in the Law when joined to trustworthiness.

➤ **Indeed, the best one you can hire is the strong and the trustworthy.** ➤

(Al-Qasas: 26)

➤ **And He has increased him abundantly in knowledge and stature.** ➤

(Al-Baqarah: 247)

God praised Talut for combining breadth of knowledge with bodily strength, signaling that complete leadership unites

strength of mind and body. In the Sunnah the Prophet (peace be upon him) said:

«The strong believer is better and more beloved to God than the weak believer, though in each there is good.»

Reported by Muslim

Strength here includes bodily strength as well as strength of faith and resolve; its mention in the context of preference points to the desirability of caring for the body. It is authentically reported that the Prophet (peace be upon him) taught that the body has a right over its owner:

«Indeed, your body has a right over you.»

Agreed upon

As for the well-known encouragement to teach children “swimming, archery, and horse-riding,” the more established view is that it is a saying of ‘Umar ibn al-Khattab (a companion's report), not a sound prophetic hadith—yet it is sound in meaning for cultivating bodily strength. Authentically

established in the Sunnah are the Prophet's foot race with 'A'ishah, the Companions' foot races, his wrestling with Rukanah, and his encouragement of the archers of Aslam.

In the balance of the Law, then, exercise is called for so long as it is a means to beneficial strength, disciplined by the Law's bounds of modesty, avoidance of excess, and not being distracted from obligatory duties. Thus the wisdom of the Law meets the summary of science: caring for the body is both a trust and an act of worship.

Conclusion

We have reached the end of this journey, and it is now clear that exercise is no luxury to be postponed but a health necessity to which science testifies with its strongest evidence. We have seen how it protects the heart, guards against diabetes, builds muscle and bone, nourishes the brain and clears the mood, and how a modest dose of movement makes a difference in both the length and quality of life.

Three great messages we hope will remain after these pages are closed: first, that a little activity is better than none, so let perfection not keep you from beginning. Second, that consistency matters more than intensity or timing; a small habit that endures is better than a zeal that fades. Third, that balance—between aerobic, resistance, flexibility, and balance work, and between training, rest, nutrition, and sleep—is the secret of sustainability and safety.

So begin today with a single step, and let your body be a trust you tend, for within it are signs of the Creator deserving of

thanks through good care. We ask God to grant us health in our bodies and strength in His obedience.

And God knows best.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع باحثٌ في قسم أمراض الكلى بجامعة ميشيغان (University of Michigan)، متخصصٌ في البحث العلمي والتحليل الجينومي (transcriptomics) لأمراض الكلى المزمنة، ومؤلفٌ غزير الإنتاج في العلوم الطبية والدراسات الإسلامية والفكرية والتاريخ. يجمع في كتبه بين الدقة العلمية المستندة إلى البيئة ووضوح العرض، ويحرص على تقديم المعرفة في قالبٍ ثنائي اللغة (عربي وإنجليزي) يجعلها في متناول أوسع شريحةٍ من القراء.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a is a researcher in the Division of Nephrology at the University of Michigan, specializing in scientific research and the transcriptomic analysis of chronic kidney disease, and a prolific author in the medical sciences, Islamic and intellectual studies, and history. His books combine evidence-based scientific precision with clarity of presentation, offered in a bilingual (Arabic–English) form to reach the widest possible readership.

مؤلفات المؤلف

من إصدارات المؤلف:

- نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (2026)
- أهمية الرياضة في حياتنا – دليل علمي شامل (2026)

Author's Publications

- نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (2026)
- أهمية الرياضة في حياتنا – دليل علمي شامل (2026)

عن الكتاب

كتاب علمي يوضح لماذا صارت الرياضة دواء لا غنى عنه، مستندا إلى أقوى الأدلة من المراجعات المنهجية والتجارب المعاشة. يعرض أنواع التمارين وأهمها فعالية، وأهم عضلات الجسم وكيفية تدريبها، وأفضل الأوقات لممارستها، والجرعة الموصى بها عالميا، مع الوقاية من الإصابات ونظرة الإسلام إلى قوة البدن.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع، باحث في قسم أمراض الكلى بجامعة ميشيغان، ومؤلف في العلوم الطبية والدراسات الإسلامية والفكرية، يجمع بين الدقة العلمية ووضوح العرض في كتب ثنائية اللغة تجعل المعرفة في متناول القارئ العربي والإنجليزي.